

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-03-27T15:55:07

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371

Generated at: 2026-03-27T15:55:01

病理辅助角色声明

作为资深病理辅助助手，我的核心职责是基于提供的病理文本、图像信息及预测类别，为Query Case: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371提供精确的临床指标提取与辅助诊断意见。我将综合分析三份参考诊断报告、20张高注意力patch图像以及TCGA-STAD预测类别，确保最终结论准确且逻辑一致。值得注意的是，我仅扮演辅助角色，不进行最终诊断签发，所有推断和建议均严格限于Query Case本身，绝不会将检索到的其他病例作为主诊断对象。在处理过程中，我会遵循严格的证据推理原则，优先采用文本中的具体数值与明确描述，并在信息冲突时显式列出并解释最终采纳的理由。

推理过程与证据归纳

推理过程与证据归纳：

首先，我们从三份参考诊断报告中提取关键信息。第一份报告（TCGA-RD-A8MW）描述了胃活检显示低分化腺癌，伴有轻度活动性中度慢性幽门螺杆菌相关性胃炎，淋巴结状态为N0，远处转移为M1，提示存在远处转移。第二份报告（TCGA-BR-7957）提供了肿瘤大小的具体数据，即4.00厘米，并未提及及其他详细病理特征或分期信息。第三份报告（TCGA-BR-A4PF）指出肿瘤为低分化，大小为10.00厘米，但同样缺乏详细的分期和淋巴结状态信息。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，可以观察到细胞形态学特征与低分化腺癌相符，表现为细胞核异型性明显、核分裂象增多以及组织结构紊乱等特征。这些形态学特征与上述参考报告中的低分化腺癌描述一致，进一步支持了Query Case可能属于低分化腺癌的判断。

此外，Query预测类别为TCGA-STAD（胃癌），这与参考报告中的病理类型相吻合。然而，关于肿瘤大小、淋巴结状态及远处转移情况，在Query Case的文本报告中并未提供具体数值或描述，因此需要结合图像证据进行推测。根据Query patch图像，虽然无法直接测量肿瘤大小，但细胞密集程度和浸润范围提示肿瘤可能具有一定的体积，但具体大小仍需谨慎评估，避免过度推测。同时，由于缺乏明确的淋巴结和远处转移图像证据，目前无法确定具体的N分期和M分期。

综合以上分析，参考报告提供的低分化腺癌特征、Query patch图像的形态学支持以及Query预测类别的佐证，我们可以初步推断Query Case为低分化胃腺癌。但由于关键临床指标如肿瘤大小、淋巴结状态和远处转移情况在Query Case中缺失，最终分期和更详细的诊断还需进一步补充完整的信息。本结论针对Query Case: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371，强调了现有证据的支持与不足，并指出了

后续诊断中需要关注的重点。

关键指标提取

关键指标提取

在综合分析Query Case: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371的病理信息时，我们参考了三份相似病例报告、20张高注意力patch图像以及预测类别TCGA-STAD。首先，从参考诊断报告中提取到的关键信息包括肿瘤大小、分级和部分分期数据。

第一份参考报告（TCGA-RD-A8MW）描述了胃活检显示低分化腺癌，淋巴结状态为N0，远处转移为M1，提示存在远处转移。然而，该报告未提及具体的肿瘤大小和T分期。第二份报告（TCGA-BR-7957）提供了较为详细的肿瘤大小信息，指出肿瘤大小为4.00厘米，但未提供其他分期或分级信息。第三份报告（TCGA-BR-A4PF）则提到肿瘤为低分化，大小为10.00厘米，但同样缺乏详细的分期数据。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，这些图像主要展示了肿瘤区域的细胞形态和组织结构，支持了低分化腺癌的诊断。图像中可见肿瘤细胞异型性明显，核分裂象较多，符合低分化特征。然而，图像并未直接提供肿瘤大小、淋巴结状态或具体分期的量化信息。

根据Query Case预测类别TCGA-STAD，进一步佐证了胃癌的可能性。综合上述证据，可以推测Query Case的肿瘤可能为低分化腺癌，但具体的肿瘤大小、T/N/M分期及淋巴结状态仍需进一步明确。由于文本报告与图像推断均未提供确切的肿瘤大小和淋巴结状态，我们无法准确确定T/N/M分期。

因此，在现有信息基础上，我们可以初步总结：Query Case表现为低分化腺癌，但具体的肿瘤大小、T分期、N分期（阳性数/总数）、M分期以及免疫组化结果（ER/PR/HER2、Ki-67）等关键指标尚无法可靠提取，需要进一步的临床资料和病理检查来确认。本结论针对 Query Case:

TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371。

初步病理辅助结论

初步病理辅助结论

基于提供的三份参考诊断报告、Query Case的20张高注意力patch图像以及预测类别（TCGA-STAD），综合分析后得出以下初步病理辅助结论。本结论针对 Query Case:

TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371。

首先，从参考诊断报告中提取的关键信息显示，病例TCGA-RD-A8MW描述了胃活检结果为低分化腺癌，伴有N0 M1的淋巴结和远处转移状态，提示存在远处转移。另一病例TCGA-BR-7957提供了肿瘤大小为4.00厘米的信息，而TCGA-BR-A4PF则描述了低分化肿瘤，大小为10.00厘米。这些报告共同指向了胃癌（STAD）的可能性，并且强调了肿瘤的低分化特征和可能的远处转移。

结合Query Case的20张高注意力patch图像，观察到的组织学特征与低分化腺癌相吻合，进一步支持了TCGA-STAD的预测类别。图像中可见的细胞形态不规则、核分裂象增多等特征，均符合低分化腺癌的典型表现。然而，由于缺乏具体的测量数据，无法直接从图像中确定肿瘤的确切大小和分期。

根据Query Case被预测为TCGA-STAD类别的高概率（接近100%），并结合上述参考报告和图像证据，可以推测Query Case很可能表现为低分化腺癌。虽然具体肿瘤大小和淋巴结状态在当前文本和图像证据中未明确提及，但考虑到TCGA-STAD的特性及参考病例中的描述，推测该病例可能具有较大的肿瘤体积和潜在的远处转移风险。

鉴于以上分析，初步病理辅助结论如下：Query Case表现出低分化腺癌的特征，与TCGA-STAD分类一致。肿瘤的具体大小和淋巴结状态需进一步临床检查确认，但根据参考病例，可能存在较大肿瘤体积和远处转移的风险。建议进行详细的影像学检查和淋巴结评估以明确分期，并考虑免疫组化检测以进一步表征肿瘤生物学行为。

本结论针对 Query Case: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371，所有推理过程严格遵循了提供的参考报告、图像证据和预测类别，确保了结论的准确性和合理性。